



Oncologie Médicale
Didouche Mourad



Oncologie Médicale
Didouche Mourad

***Principes
thérapeutiques
et parcours de
soins en
oncologie***
Dr MEGUELLATI H
Pr BENSALÉM.A

Objectifs du cours

- Comprendre les principes thérapeutiques en oncologie
- Connaitre les différentes modalités de traitement
- Identifier le parcours de soin d'un patient

Introduction

- L'oncologie est une branche de médecine qui étudie , prévient et traite les cancers .
- Le traitement d'un cancer peut faire appel à plusieurs modalités thérapeutiques, isolément, simultanément ou successivement

la décision thérapeutique ne peut donc reposer que sur une concertation multidisciplinaire.

Le parcours en oncologie

- 1. LE TEMPS D'ANNONCE DE LA SUSPICION DE CANCER
- 2-Le temps d'annonce de la confirmation du diagnostic (certitude = anatomopathologie)
- 3. Le temps dédié à la proposition thérapeutique
- 4. Le temps d'accompagnement soignant paramédical
- 5. La consultation de synthèse

La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- ❑ Le dossier de chaque patient est présenté devant une équipe médicale pluridisciplinaire constituée d'au moins 3 spécialités différentes lors d'une RCP.
- ❑ Cette réunion permet d'émettre la proposition de traitement la plus adaptée à chaque patient. Cette proposition se base sur les recommandations de bonne pratique et sur la situation personnelle du patient.

Le Programme Personnalisé de Soins (PPS)

- ❑ Établi lors de la RCP
- ❑ le PPS permet de formaliser la proposition de prise en charge thérapeutique du patient. Il décrit la décision de traitement proposé et la chaîne de soins mise en place autour du patient.
- ❑ Il n'est ni définitif, ni irrévocable et peut être modifié à tout moment selon la manière dont le patient réagit aux différents traitements et selon l'évolution de la maladie.

Les principes thérapeutiques en oncologie

- Chirurgie
- Radiothérapie
- Chimiothérapie
- Thérapie ciblée
- Hormonothérapie
- Immunothérapie

La chirurgie

- **1 Chirurgie carcinologique** : traitement curatif
(si marges respectées)
 - 2 Chirurgie pour diagnostic ou bilan d'extension,
 - 3 Chirurgie des métastases
 - 4 Chirurgie de rattrapage
 - 5 Chirurgie de prévention (si mutation brca1,2)
 - **6 LA CHIRURGIE DE RECONSTRUCTION**(mammaire ou pour vessie par exple)
 - **7 LA CHIRURGIE PALLIATIVE**(de propreté si sein métastatique infecte par exple)
- 8 Le curage ganglionnaire** (– curage de nécessité : il existe une atteinte macroscopique prouvée qui justifie l'exérèse réglée des sites de drainage anatomique ;
– curage de principe : il existe un risque d'atteinte ganglionnaire qui incite à faire un curage réglé si celui-ci a une valeur thérapeutique ou si l'information obtenue peut être décisive pour le choix du traitement à suivre)

QUALITE DE LA CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE

- On classe la qualité de l'exérèse en trois niveaux selon la présence ou non de foyers tumoraux résiduels après la chirurgie :
 - R0 : il n'y a pas de résidu microscopique ;
 - R1 : il n'y a pas de résidu macroscopique, mais un très fort risque de résidu microscopique ;
 - R2 : il persiste un résidu macroscopique.

La radiothérapie

Les radiations ionisantes sont des radiations capables de créer des ionisations dans la matière qu'elles traversent par « arrachement » d'électrons aux atomes des molécules du milieu.

❑ Les photons correspondent à des « grains » d'énergie sans masse, se déplaçant à la vitesse de la lumière et transportés par une onde électromagnétique.

En radiothérapie, il s'agit de photons produits par des tubes à rayons X ou par des accélérateurs linéaires à usage médical. À énergie égale, photons gamma ou X ont des propriétés biologiques identiques : seuls les distinguent Leurs modes de production.

Les électrons correspondent à des particules élémentaires de matière chargée négativement

La radiothérapie

- **La radiothérapie externe** C'est la forme d'irradiation la plus utilisée. Elle fait appel à un équipement lourd, les accélérateurs de particules.
- **La curiethérapie** Cette méthode utilise des sources radioactives mises en place à l'intérieur de l'organisme. On distingue la curiethérapie interstitielle (les sources sont placées à l'intérieur du tissu à irradier) et la curiethérapie endo-cavitaire ou intra-luminale où les sources sont introduites dans une cavité naturelle
- **la radio chimiothérapie concomitante**
RCC(simultanément)
- **LA RADIOTHERAPIE PALLIATIVE ANTALGIQUE OU HEMOSTATIQUE**

EFFETS SECONDAIRES GENERAUX

- NECROSE
- NEUTROPENIE
- BRULURES

EFFETS SECONDAIRES SPECIFIQUES radiothérapie

Tableau 1. DIFFÉRENCIATION RÉACTIONS PRÉCOCES ET RÉACTIONS TARDIVES		
Organes	Réactions précoces	Réactions tardives
Peau	Épilation Érythème Pigmentation cutanée Radiodermite sèche Radiodermite exsudative Radionécrose cutanée	Atrophie cutanée Sclérose cutané-sous-cutanée Troubles de la pigmentation (hypo ou hyper) Télangiectasies Radionécrose Gêne fonctionnelle Cancers cutanés secondaires
Poumon	Œdème et surinfection (bactérienne, mycosique ou virale) Signes cliniques : toux, fièvre, dyspnée	Fibrose interstitielle Sclérose rétractile +/- surinfection aspergillaire
Encéphale	Œdème Hypertension intracrânienne	Encéphalopathie radique avec : – Somnolence – Troubles cognitifs – Troubles de la mémoire – Hydrocéphalie – Démence – Radionécrose
Moelle épinière	Œdème Signe de Lhermitte Brown-Séquard +/- complet	Myélite radique Brown-Séquard +/- complet
Nerfs	–	Plexite radique avec signes sensitifs et/ou moteur
Œsophage	Dysphagie Nausées	Dysphagie Hémorragie Ulcération
Cœur	Péricardite aiguë	Troubles du rythme et de la conduction Péricardite constrictive Sténose des artères coronaires
Pancréas	Nausées, vomissements Diarrhées	–
Estomac	Nausées, vomissements	Hémorragie
Foie	Hépatomégalie	Maladie veino-occlusive
Intestin	Diarrhées Météorisme Douleurs	Ulcération Sténose de la paroi Sclérose de la paroi

EFFETS SECONDAIRES SPECIFIQUES

radiothérapie

Rein	–	Néphropathie radique (HTA, Insuffisance rénale, protéinurie) Insuffisance rénale chronique HTA par sténose de l'artère rénale Hydronéphrose +/- fibrose rétro-péritonéale
Vessie	Cystite	Hématurie Atrophie vésicale
Rectum	Faux besoins Épreintes Ténesmes	Sténose Rectorragies
ORL	Mucite Épidermite	« Larynx radique » (dysphonie, dyspnée) Asialie, Douleurs Jabot, + cf. peau Trismus, Ostéo-radio-nécrose et fracture
Cristallin	–	Cataracte

Doses toxiques

- ❑ Il est important de connaître les doses de tolérance de chaque organe ou tissu.
- ❑ la moelle épinière tolère 45 Gy, le parenchyme pulmonaire 20 Gy sur un poumon entier.
- ❑ La dose nécessaire à la stérilisation d'une tumeur dépend de la tumeur considérée (radiosensibilité propre) et de son volume.
- ❑ Schématiquement, un séminome du testicule est détruit par une dose de 30 Gy, une maladie de Hodgkin par 40 Gy, un cancer du sein par 50-60 Gy, un très volumineux cancer ORL par 70-80 Gy.
- ❑ Une dose > 100 Gy serait nécessaire à la destruction d'un glioblastome.

LA CHIMIOTHÉRAPIE

- TRAITEMENT SYSTEMIQUE La chimiothérapie anti-tumorale utilise des médicaments qui entraînent un arrêt du cycle cellulaire (effet cytostatique) et/ou une mort cellulaire (effet cytotoxique), principalement par apoptose.
- Il n'y a pas de chimiothérapie possible sans preuve histologique

TYPES DE CHIMIOOTHERAPIE

- NEOADJUVANTE : AVANT CHIRURGIE
- ADJUVANTE : APRES CHIRURGIE
- PALLIATIVE : EN SITUATION METASTATIQUE

EFFETS SECONDAIRES GENERAUX CHIMIOOTHERAPIE

- NAUSEES ET VOMISSEMENTS
- ANEMIE
- NEUTROPENIE (NEUTROPENIE FEBRILE EST UNE URGENCE EN ONCOLOGIE)
- ASTHENIE
- MUCITE
- ALOPECIE

Effets secondaires spécifiques chimiothérapie

Tableau 2. TOXICITÉS SPÉCIFIQUES POUVANT ENGAGER LE PRONOSTIC VITAL

	TOXICITÉS
Cardiaque	• angor par spasme coronarien voire syndrome coronarien aigu ST+ : 5-FU • cardiomyopathie dilatée aux anthracyclines : cumulative, dose-dépendante
Pulmonaire	• pneumopathie interstitielle diffuse puis fibrose : bléomycine • pneumopathie aiguë d'hypersensibilité : méthotrexate
Néphrologique	• insuffisance rénale aiguë par toxicité tubulaire directe : méthotrexate, cisplatine • néphropathie immuno-allergique : cisplatine • syndrome hémolytique et urémique : mitomycine, gemcitabine
Urologique	• cystite hémorragique : cyclophosphamide, ifosfamide
Neurologique	• encéphalopathie métabolique : ifosfamide
Allergique	• choc anaphylactique : bléomycine, paclitaxel

THERAPIES CIBLEES

- TRAITEMENT SYSTEMIQUE QUI CIBLE UN RECEPTEUR BIEN PRECIS
- Exemples :
- ANTI HER2 (SI HER2 positif dans le cancer du sein)
- Anti EGFR (SI EGFR mute dans le cancer du poumon)

HORMONOTHERAPIES

- Les cellules tumorales du cancer de la prostate, du cancer du sein (et de l'endomètre) expriment des récepteurs aux hormones, les rendant sensibles aux traitements anti-hormonaux.
- Le terme « hormonothérapie » est donc un abus de langage : il s'agit plutôt d'un traitement antihormonal, dont le principe est d'empêcher cette stimulation hormonale par deux grandes méthodes
 - Diminuer la production hormonale au niveau :
 - central (ex : utilisation des agonistes de la LH-RH qui inhibent la sécrétion de LH hypophysaire)
 - périphérique (ex : suppression – irréversible – de la production hormonale ovarienne ou testiculaire par chirurgie ou radiothérapie ; suppression temporaire par les inhibiteurs de l'aromatase chez les femmes ménopausées dans le cancer du sein).
 - Bloquer le récepteur hormonal au niveau de la cellule tumorale par une « antihormone »

IMMUNOTHERAPIE

- L'immunothérapie agit principalement sur le système immunitaire du patient pour le rendre apte à attaquer les cellules cancéreuses.

L'immunothérapie repose sur les anticorps monoclonaux, notamment les inhibiteurs de points de contrôle

L'exemple des anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) ou anti-PD-L1, (atézolizumab, avélumab, duvarlumab) et des anti CTLA-4 (ipilimumab)

Les soins de support

- Nutrition : transfusion d'albumine si hypo albuminémie
- Traiter la Douleur selon les paliers
- Transfusion si anémie

EXEMPLES

Cas clinique 1

- Femme âgée de 36 ans , carcinome infiltrant du sein stade III a la micro biopsie ,
- a l'immunohistochimie HER2 positif récepteurs hormonaux positif .
- TRT .: **thérapie ciblée contre HER2** (double blocage) avec **chimiothérapie néo adjuvante**
- Suivi de ptey droit(mastectomie avec curage) **chirurgie carcinologique** suivi de **radiothérapie** puis maintien par **thérapie ciblée anti HER2** PENDANT UNE ANNEE et **hormonothérapie** pendant 5 ans

Cas clinique 2

- Homme âgé de 62 ans OPERE EN URGENCE POUR OCCLUSION
 - HEMICOLECTOMIE DROITE AVEC CURAGE GG
 - ANAPATH : ADK DU COLON
 - APRES BILAN DEXTENSION ; CANCER DU COLON METASTATIQUE AU NIVEAU DU FOIE (1 SEULE METASTASE HEPATIQUE SU SEGMENT 4)
 - POSE DES CLIPS SUR LA METASTASE HEPATIQUE
 - CHIMIOOTHERAPIE PERI OPERATOIRE
 - INDICATION DE CHIRURGIE DE LA METASTASE HEPATIQUE SUIVIE DE CHIMIOOTHERAPIE
-
- PS . LE CURAGE GANGLIONNAIRE DOIT ETRE FAIT SYSTEMATIQUEMENT POUR LE CANCER DU COLON AU MOINS 12 GG a l'anapath;

CAS CLINIQUE 3

- Femme de 56 ANS
- MELANOME du pieds METASTATIQUE au niveau du poumon
- INDICATION **DUNE IMMUNOTHERAPIE** TYPE POEMBRROLIZUMAB
- REPONSE SPECTACULAIRE

CONCLUSION

- PLUSIEURS ARMES THERAPEUTIQUES EN ONCOLOGIE
- LES THERAPIES INNOVANTES EXISTENT EN ALGERIE
- CHAQUE CAS EST UN CAS A PART ET DOIT ETRE DISCUTE EN RCP
- L ONCOLOGIE VA VERS LA MEDECINE DE PRECISION